眼内注药后非感染性眼内炎症

2025 专家共识 · 正面

症状与时间

多数末次10 d内，高剂量抗VEGF有约1周/首次4周双峰〔强推荐〕。显著视力下降/畏光立即就诊；持续2 d以上不适或飞蚊及时就诊。

2025 刊p496–497、500–501

先鉴别感染

视力/眼压/前节/散瞳眼底；排感染及其他伪装。无明显疼痛不能据此排感染；激素无效重新排查感染。

2025 刊p500–501

排查RV/RO

引导眼位超广角照相、FFA看周边灌注〔强推荐〕；FFA禁忌可OCTA，混浊每次B超。初阴性仍需找延迟RV/RO。

2025 刊p500

随访与预防

第1天/1周/4周；确诊缩短至炎症静止。高危避免双眼同期；ST-TA不作常规预防〔中等推荐〕。

2025 刊p499–501

原文摘录；处方前核对。详见提取表与原文缺项。
100%原尺寸 · 双面长边翻转

眼内注药后非感染性眼内炎症

2025 专家共识 · 背面

局部与RV剂量

无RV/RO：滴眼4次/d至1次/h；TA结膜下4～8 mg、球旁20～40 mg、球内1～2 mg。RV口服泼尼松龙0.5～1.0 mg/(kg·d)。

2025 刊p502

RO剂量摘录

RO：泼尼松龙1.0 mg/(kg·d)，或甲泼尼龙静滴500～750 mg、1次/d；TA球旁20～40 mg/球内1～4 mg。须个体化，球内TA超说明书。

2025 刊p502

阶梯与禁忌

按部位/RV/RO升级〔中等推荐〕。活动期避免相同/同类药再注；TA相关者避免再玻璃体TA。普通SIOI激光待炎症消退后适应证。

2025 刊p502

预后与缺项

黄斑缺血/RO可逆性影响预后〔中等推荐〕。HOCRV另走特殊路径。统一激素疗程/递减、复诊增频间隔未明确。

2025 刊p502–503